Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?
Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, z. B. Belastung oder nach dem Essen?
Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie wieder weg?
Ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome?
Sind die Schmerzen mit der Zeit schlimmer geworden?
Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
Sind die Schmerzen von Anfang an im Unterbauch oder sind sie von einem anderen Ort in den Unterbauch gewandert?
Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen stechend oder dumpf?
Wie stark sind die Schmerzen?

Haben Sie Kaltschweiß, Herzrasen, schnellere Atmung, Müdigkeit oder Schwindel bemerkt?

Ist Ihr Bauch dicker und härter geworden?
Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, z. B. Bewegung, oder etwas, das sie lindert, z. B. Hinlegen?
Haben Sie etwas gegen die Schmerzen genommen?

Wurden Sie schon einmal operiert?

Haben Sie Fieber?
Seit wann?
Haben Sie die Temperatur gemessen?
Wie hoch war sie?
Wo haben Sie gemessen?
Haben Sie Schüttelfrost?

Schwitzen Sie mehr als sonst oder haben Sie Schweißausbrüche bzw.
Nachtschweiß?

Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?
Seit wann?
Wie oft?
Wie sah das Erbrochene aus? Welche Farbe und Konsistenz hatte es?
Gab es Blut im Erbrochenen?

Haben Sie Probleme beim Stuhlgang?
Seit wann?
Wie oft?
Welche Farbe und Konsistenz hat der Stuhl?
Gibt es Blut im Stuhl?

Haben Sie Probleme beim Wasserlassen?
Haben Sie Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen?
Welche Farbe hat der Urin?
Gibt es Blut im Urin?

Wie ist Ihr Appetit?
Haben Sie Völlegefühl oder Blähungen?

Wann hatten Sie das letzte Mal Ihre Monatsblutung?
Kann es sein, dass Sie schwanger sind?
Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie einen ungewöhnlichen vaginalen Ausfluss haben?
Gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt?
Wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrem Frauenarzt / Ihrer Frauenärztin?
War alles in Ordnung?

Können Sie wegen der Schmerzen schlecht schlafen?
Fühlen Sie sich müde?

Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?

Welche Aufputschmittel nehmen Sie?

Am Ende des Gesprachs Aufklarung

Ich habe einen Verdacht auf eine Blindarmentzündung. und wenn es die richtige Diagnose ist, müssen Sie operiert werden. Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde zuerst körperliche Untersuchung machen, dann Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich eine Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?
Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen, erzähle Ihnen alles

Sonographie – Ultraschall:
Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet. Das ist nicht nur bei Schwanger, wir können damit alle inneren Organe beobachten.
Haben Sie noch Fragen an mich?

Appendektomie:
Ihre Beschwerden weisen darauf hin, dass Sie eine Entzündung Ihres Wurmfortsatzes am Blinddarm haben, daher raten wir zur operativen Entfernung.
Heutzutage ist die Operation mittels Bauchspiegelung das Standardvorgehen.
Die Operation erfolgt unter voll Narkose über einen 1 - 2 cm großen Schnitt im Bereich des Nabels wird ein dünnes Rohr (Trokar) für die Laparoskop-Kamera eingebracht.

Dann wird der Bauch mit Kohlendioxid-Gas aufgeblasen und der Bauchraum mit Hilfe der kleinen Videokamera sichtbar gemacht.
Hierauf erfolgt das Einbringen 2 - 3 zusätzlicher Trokare über weitere kleine Schnitte. Über diese werden die für die Operation nötigen Instrumente eingeführt.
Das Wurmfortsatzes kann dann entfernt werden.
Beim Verschluss der Wunde werden kleine Schläuche (Wunddrainagen) zum Ableiten von Wundflüssigkeit oder Blut nach außen geführt. Dann müssen Sie bei uns für ein paar T agen zur Beobachtung bleiben.
Komplikationen treten aber sehr selten auf, wie Nachblutung, Infektionen sowie Wundheilstörungen.

ARZT-ARZT GESPRACH

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen.
Bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von 2,6 mmol/L hat. Dieser Wert ist deutlich erniedrigt und entspricht einer Hypokaliämie.

Jetzt berichte ich über den Fall meiner Patientin.

Es geht um Frau Naomi Rosenthal. Sie ist 48 Jahre alt, am 28.03.1975 geboren, 161 cm groß und wiegt 59,9 kg.
Sie stellt sich bei uns wegen seit zwei bis drei Tagen bestehender Bauchschmerzen im rechten Unterbauch vor.
Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten.
Sie berichtet, dass die Schmerzen von periumbilikal in den Unterbauch gewandert sind und die Schmerzintensität bei 8/10 auf der Schmerzskala liegt.
Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen stechend, ziehend, persistierend und progredient.

Die Schmerzen verschlimmern sich bei Bewegung.
Sie erwähnt, dass sie vor 3 Tagen zur Untersuchung beim Hausarzt war, jedoch ohne auffällige Ergebnisse.
Begleitend klagt sie über Fieber (gestern Abend 38,8 °C, heute Morgen 39,9 °C), Nausea seit gestern Abend, Vomitus heute Morgen zweimal, flüssig und gelblich,

Diarrhoe heute Morgen einmal, wässrig und braun, sowie Inappetenz seit gestern Abend.
Außerdem hat sie eine irreguläre Menstruation. Die letzte Periode war vor 40 Tagen.

Vegetativanamnestisch ergaben sich schmerzbedingte Insomnie, Müdigkeit und Hyperhidrose.
Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte sie eine Hypothyreose seit 10 Jahren, die mit L-Thyroxin 100 µg behandelt wird, sowie Kopfschmerzen, die 1–2 Mal pro Monat bestehen, wogegen sie Ibuprofen nimmt. Die weitere Medikamentenanamnese war unauffällig.
Als Operation gab sie eine Tonsillektomie an, die vor 10 Jahren durchgeführt wurde. Damals sei vermutlich eine Sepsis entstanden. Deswegen musste sie mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben.
Bei der Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von L-Thyroxin 100 µg (1-0-0) und Ibuprofen 400 mg (1-0-0).
Die Allergieanamnese war unauffällig.
Bei der Noxenanamnese berichtet sie von zwei Gläsern Wein am Wochenende und von Speed, wenn sie Stress hat.
Die Familienanamnese ergab einen Myokardinfarkt beim Vater und eine Knieoperation bei der Mutter.
Sozialanamnestisch ist sie im IT-Bereich tätig, ledig und in einer homosexuellen Beziehung.
Sie hat keine Kinder.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Appendizitis hin.
Die wandernden Bauchschmerzen von periumbilikal in den Unterbauch, Fieber, Nausea und Inappedenz sprechen dafür.
Differentialdiagnostisch kommen eine Urolithiasis, Morbus Crohn (ilk atak oalbilir belki), Extrauteringravidität(homoseksüel ilişki o yüzden söyleme), Adnexitis oder Ovarialtorsion in Betracht.
Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen. Bei der körperlichen Untersuchung suche ich nach positivem McBurney-Punkt, positivem Lanz-Punkt und positivem Blumberg-Zeichen.
Im Labor würde ich ein großes Blutbild, Entzündungsparameter (CRP), β-HCG, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Cholestaseparameter, einen Urinstatus sowie eine Stuhldiagnostik (FOBT – Fecal Occult Blood Test) kontrollieren lassen.
Anschließend werde ich eine Sonographie des Abdomens, ein Röntgen-Abdomen sowie ggf. eine CT-Abdomen durchführen und ein Konsil in der Abteilung für

Chirurgie anfordern.
Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, sollte die Patientin stationär aufgenommen werden.
Als initiale Therapie empfehle ich Nahrungskarenz, Flüssigkeitszufuhr sowie die Gabe eines Analgetikums (z. B. Metamizol), eines Antiemetikums und eines Antibiotikums (z. B. Ceftriaxon und Metronidazol).
Als kausale Therapie kommt eine laparoskopische Appendektomie in Betracht.

DOC-CHECK NOTLAR

„Eine Intervallappendektomie ist die geplante Entfernung des Appendix einige Wochen nach konservativer Behandlung einer akuten Appendizitis."

Phlegmonöse Appendizitis = apendiksin duvarının tamamen iltihaplandığı, ödemli ve infiltre olduğu akut apandisit tipi.

Cefuroxim+Metranidazol oder Piperacillin+Tazobactam- Doc-check

„Ceftriaxon ist ein Cephalosporin der dritten Generation mit breiterem Wirkspektrum und guter ZNS-Gängigkeit für schwere Infektionen, während Cefuroxim ein Cephalosporin der zweiten Generation für leichtere bis mittelschwere Infektionen ist."

Sunumdan sonra şu cümle **çok profesyonel izlenim bırakır:**

„Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen jetzt begründen, warum Appendizitis am wahrscheinlichsten ist und wie wir zwischen den Differentialdiagnosen unterscheiden."

Akute Appendizitis

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Rosalin Rosenthal
Alter: 45 Jahre (geb. am 1.07.1978)
Größe: 1,77 m
Gewicht: 64 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

Hauptbeschwerde:

- seit 4 T. plötzlich aufgetretene, bestehende, progrediente, ziehende und stechende Bauchschmerzen im rechten Unterbauch, ohne Ausstrahlung
- Schmerzwanderung vom periumbilikalen Bereich in den rechten Unterbauch
- Die Schmerzintensität: 8/10 auf der NRS
- Auslöser: Keine (plötzlich beim Treppensteigen aufgetreten)
- Lindernde Faktoren: Keine
- Verstärkende Faktoren: Bewegung
- Begleitsymptome:
  - Hyperhidrose
  - Nausea
  - Emesis: 2 Mal, heute Morgen (Essensreste)
  - Diarrhö (wässrig, 1-mal, heute Morgen)

V/A:

- Inappetenz
- Fieber: seit gestern Abend, 38,9 °C.
- schmerzbedingte Dyssomnie

V/E:

Hypothyreose, seit 10 J., kontrolliert.

M:

L-Thyroxin 100 µg 1-0-0.

Vor-op:

Tonsillektomie (TE) mit 12 LJ. Kompliziert durch Sepsis, stationär für 14 Tage.

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

unauffällig

- **Genussmittel/ Drogen:**

- Nikotinkonsum: Nichtraucherin
- Alkoholkonsum: wurde verneint
- Drogenkonsum: Amphetamin, alle 2 Wochen.

- **Sozialanamnese:**

Web- designerin
Ledig, in einer homosexuellen Beziehung
keine kinder

- **Familienanamnese:**
  Vater: Z.n. MI vor 2 Jahren
  Mutter: Z.n. Knie-OP vor 6 M.
  Schwester: M. Crohn.

- **Verdachtsdiagnose:**
  Akute Appendizitis

- **Differentialdiagnose**
  Urolithiasis
  Divertikulitis

- **weitere Diagnostik**
- KU
- Labor: großes BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte - β-HCG
- Urinstatus
- Sono Abdomen
- Ggf CT Abdomen
- Chirurgisches Konsil

- **Therapievorschläge**
- Stationäre Aufnahme
- Nahrungskarenz
- Flüssigkeitszufuhr
- Laparoskopische Appendektomie
- Antibiotikum Einmal, Cephalosporin prä-OP
- Symptomatische Therapie: Analgetikum, Antiemetikum.

Die Appendix vermiformis kann retrozäkal (90%), pelvin (10%), subzäkal, präileal, postileal liegen am häufigsten retrozäkal

Je nach Lage der Appendix vermiformis variiert die Schmerzlokalisation

Abbruch machen → Schwangerschaftsabbruch

wir können innerhalb 12 bis 14 Wochen Abbruch machen

bei medizinische Indikation können wir irgendwann Abbruch machen (Chirurgen)

Medikamentös beenden bis 9. Woche

Während der Schwangerschaft machen wir MRT bei Verdacht auf Appendizitis

laparoskopische 2. Trimester 12-24 Woche

offene OP 3. Trimester 8/9

1

20. Akute Appendizitis s.19 (neue)

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

Die Patientin hat ihre Rolle sehr gut gespielt und ich hatte das Gefühl, dass sie ehrlich schmerzen hat. a ber sie hat deutlich gesprochen

- ich habe diese Informationen bereits Ihren Kollegen am Eingang gegeben, warum fragen Sie noch einmal nach dem Namen? ✓ Ich muss das genaue Geburtsdatum wissen, um Sie nicht mit anderen Patienten mit gleichem Namen und Alter zu verwechseln.

- Anna-Lena Röber / Naomi Rosenthal / Schultin Wuller
- 48J.
- *28.03.1975
- 1,61 m
- 59,9 Kg

-Begleitsymptomatik

- **Rechtsseitige Unterbauchschmerzen**: ich habe sehr starke Schmerzen im Unterbauch, eher auf der rechten Seite
  - **seit 2-3 Tagen**
  - **plötzlich aufgetreten**
  - **persistierend, progredient**: nein nein, die Schmerzen gehen nicht weg, seit sie angefangen haben, und sie werden mit der Zeit immer schlimmer
  - eher **stechend, ziehend**
  - **Ohne Ausstrahlung**: nein ich habe nicht das Gefühl, dass sie anderswohin strahlen
  - **Die Schmerzen sind gewandert, vom Bereich um den Nabel herum in den rechten Unterbauch**
  - **keine Auslöser**: ich glaube, es ist plötzlich aufgetaucht, ohne Auslöser
  - **NRS 8/10** würde ich sagen
  - **Verstärkerende Faktoren: Bewegung**: Ja, wenn ich mich bewege, ist es schlimmer, wenn ich gehe.
  - **Vor drei Tagen Untersuchung beim Hausarzt unauffällig**: ich war gestern beim HA und er hat mir Blut abgenommen aber keine Ergebnisse noch, deswegen bin ich hierhergekommen
    - weil ich zu große Schmerzen hatte, ich konnte nicht mehr warten
    - ✓ Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, wir werden das kümmern, machen Sie sich keine Sorge

-vegetative Symptomatik

- **Fieber seit gestern Abend 38,8°C**
  - **Heute Morgen 39,9°C** Weil die Temperatur je nach Messstelle unterschiedlich sein kann und ich sie sonst nicht richtig bewerten kann.
  - **Rektal gemessen**: ich habe ihn im After gemessen, ich glaube, die Messung ist genauer
- **Nausea seit gestern Abend**: mir ist schlecht / übel
- **Vomitus heute Morgen zweimal (flüssig, gelblich, wenig Essen kein Blut)**: ja ich habe mich heute Morgen zweimal übergeben

Wie sah der Stuhl aus?

(2)

- **Diarrhö heute Morgen einmal (wässrig Braun, kein Blut):** Ich hatte auch heute Morgen Durchfall einmal
- **Inappetenz seit gestern Abend:** Ich habe seit gestern Abend nichts gegessen, ich kann wegen dieser Schmerzen nicht mehr essen
- **Schmerzbedingte Insomnie:** ich kann wegen dieser schrecklichen Schmerzen auch nicht mehr schlafen
- **Fatigue:** Müdigkeit
- **Nachtschweiß oder Hyperhidrose seit gestern:** ich schwitze auch viel

Enöncmli soru

- Sind die Schmerzen von einem Ort an einem anderen Ort gewandert? (*Um der Appendix zu bestätigen*)
- Strahlen die Schmerzen in andere Körperregion aus? (*Um die Nephrolithiasis auszuschließen*)
- Haben Sie Problem bei Wasserlassen? Schmerzen - Brennen - Blut – Harndrang (*Um die Nieren Probleme auszuschließen*)
- Glauben Sie, dass Sie im Moment schwanger sind? (*EUG*) Kann es sein, dass Sie schwanger sind?
- Haben Sie Blutspuren im Stuhl bemerkt? (*Kolonkarzinom*)
- Haben Sie noch einen Blinddarm?

-Gyn

- **Irreguläre Menstruation:** ich habe meine Periode nicht regelmäßig, aber es ist üblich, manchmal habe ich Periode nur jeden zweiten Monat
- **Letzte Periode vor 40 Tage**
- Ich verwende keine Verhütungsmittel, ich habe nur mit Frauen Geschlechtsverkehr.
- Sie können sich trotzdem eine sexuell übertragbare Infektion einfangen. Deshalb ist es wichtig, sich beim Geschlechtsverkehr zu schützen. hastalanmak, kapmak
- Ist es möglich das Sie schwanger sind? Nein, es ist unmöglich, dass ich **schwanger** bin, ich bin lesbisch (ich habe nur Geschlechtsverkehr mit Frauen)

-Vorerkrankungen

- **Hypothyreose seit 10 J kontrolliert:** ich habe seit 10 Jahren eine Schilddrüsenunterfunktion, aber mein Arzt hat vor kurzem meine Hormone kontrolliert und alles war perfekt
- **Kopfschmerzen (1-2 pro Mo klopfend):** ich leide auch an chronischen Kopfschmerzen, 1 oder 2 Mal im Monat und nehme manchmal Ibuprofen dagegen ein
  - Wie sind diese Schmerzen, und wo genau?

-Vor-OPs

- **TE mit 12 L j.**
- **Komplikation: Sepsis**
  - Ich habe meine Mandeln entfernt bekommen, als ich 12 Jahre alt war, aber die Operation ist nicht gut verlaufen. Ich hatte danach eine Blutinfektion und musste mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben.
  - Ich habe wirklich große Angst, dass es mit diesen Bauchschmerzen wieder passieren könnte.
    - Das ist eine sehr seltene Situation, und die Medizin macht Fortschritte also ist es heute nicht wirklich sehr unwahrscheinlich.

Es tut mir leid, dass Sie sowas erleben mussten.

-Medikation

- **Ibuprofen 400 mg Tbl. 1-0-0**
- **L-Thyroxin 100 µg Tbl. 1-0-0**
  - Warum fragen Sie mich das? Glauben Sie, mein Hausarzt könnte sich bei der Dosierung geirrt haben? yanılmak
    Nein ich glaube nicht, aber bestimmte Medikamente können mit anderen Wechselwirkungen haben

-Allergien

- Kein bekannt

(3)

-Noxen

- **Nikotinkonsum: Nichtraucherin,** niemals. Haben sie schon geraucht?
- **Alkoholkonsum:** 2 Gläser Wein am Wochenende
- **Drogenkonsum: Amphetamine Speed (bei Stress)**
  - Ich nehme Aufputschmittel ich nehme es gelegentlich, wenn ich Stress habe (Stress bei der Arbeit)
  - Sie wissen, ich habe einen sehr stressigen Beruf, Herr Dr.
  - Es ist in Form eines Pulvers, das durch die Nase geschnupft wird ✓
  - Das wäre besser für Ihre Gesundheit, wenn Sie mit dem Speed aufhören können. Ich kann Ihnen ein Spezialist empfehlen, wenn Sie möchten.

ich verstehe, dass Sie Stress bei der Arbeit haben.

-Sozialanamnese

- **Tätig im IT-Bereich:** ich bin IT-Ingenieurin in einem großen Unternehmen (Microsoft), ich leite ein Team und das ist manchmal sehr stressig
- **Ledig, sie will sich nächstes Jahr heiraten oder sie ist in einer homosexuellen Beziehung (lesbisch):** ich bin ledig und lebe allein, aber ich habe seit kurzem eine Freundin. Ich würde gerne eines Tages heiraten, aber ich weiß nicht, wie meine Eltern reagieren werden, wenn sie erfahren, dass ich lesbisch bin. Ich habe Angst, es ihnen zu gestehen
  - Ich verstehe, es tut mir leid, dass Sie diese schwierige Situation erleben.
- **Keine Kinder**

-Familienanamnese

- **Vater (75 J.): Z.n. MI vor zwei Jahren:** Herzanfall / Er hat jetzt auch viele Medikamente, aber es geht ihm besser.
- **Mutter (65 J.): Z.n. Knieoperation:** eine Knieoperation vor einiger Zeit, ansonsten geht es ihr sehr gut
- **Eine Schwester: Morbus Crohn:** Darmerkrankungen, Crohn oder etwas Ähnliches ✓

-Fragen

- Was habe ich Herr Dr? Warum EKG? Um eine kardiale Ursache auszuschließen. ✓
- Ich kann nicht hierher bleiben, ich muss arbeiten, wie lange ich hierher bleiben muss? Leider, wenn meine Verdachtdiagnose richtig ist, Sie müssen operiert werden. Deshalb sollen Sie hierher bleiben, vielleicht 2 oder 3 Tagen. Sie können einfach Ihre Freundin anrufen, um einige Sache zu bringen.

⇨ Ich danke Ihnen für Ihr Offenheit, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Ich habe einen Verdacht **auf Blindarmentzündung** und wenn es die richtige Diagnose ist, müssen Sie operiert werden. Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb sollen wir ein paar Untersuchungen durchführen.

Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann werde ich Ihnen Blutabnehmen. Und wir werden einen Bauch-Ultraschall durchführen. Wissen Sie was ist das?

Abdo-Sonographie: ein Ultraschall des Bauchraums

Das ist eine Schmerzfrei und Strahlenfrei Untersuchung, die dauert circa 15 Minuten. Ich trage ein Gel auf Ihren Bauch auf und mit einer Sonde können wir Ihre inneren Organe beobachten und sehen, wie es um Ihren Blinddarm bestellt ist. Das ist nicht nur bei Schwanger, wir können damit alle inneren Organe beobachten.

Haben Sie noch Fragen?

Appendektomie:
Ihre Beschwerden weisen darauf hin, dass Sie eine Entzündung Ihres Wurmfortsatzes am Blinddarm haben, daher raten wir zur operativen Entfernung.
Heutzutage ist die Operation mittels Bauchspiegelung das Standardvorgehen.
Die Operation erfolgt unter voll Narkose über einen 1 - 2 cm großen Schnitt im Bereich des Nabels wird ein dünnes Rohr (Trokar) für die Laparoskop-Kamera eingebracht.
Dann wird der Bauch mit Kohlendioxid-Gas aufgeblasen und der Bauchraum mit Hilfe der kleinen Videokamera sichtbar gemacht.
Hierauf erfolgt das Einbringen 2 - 3 zusätzlicher Trokare über weitere kleine Schnitte. Über diese werden die für die Operation nötigen Instrumente eingeführt. Das Wurmfortsatzes kann dann entfernt werden.
Beim Verschluss der Wunde werden kleine Schläuche (Wunddrainagen) zum Ableiten von Wundflüssigkeit oder Blut nach außen geführt. Dann müssen Sie bei uns für ein paar Tagen zur Beobachtung bleiben.
Komplikationen treten aber sehr selten auf, wie Nachblutung, Infektionen sowie Wundheilstörungen.

4

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um **Frau Naomi Rosenthal, 45** Jahre alt, der in leicht reduziertem AZ (Allgemeinzustand) und gutem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Sie beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit 2-3 Tagen stechende ziehende rechtseitige unterabdominale Schmerzen. Die Schmerzen begannen plötzlich in der Umbilikalregion und wanderten dann in die rechte Inguinalregion und sind seitdem progredient und persistierend. Ohne Ausstrahlung, und keine Auslöser. 8 von 10 auf einer Schmerzskala. Verstärkend ist Bewegung. Sie war gestern wegen der Schmerzen bei ihre HA, er hat einen Bluttest gemacht aber keine Ergebnisse noch.

Begleitend ist seit gestern Nausea, Hyperhidrose, schmerzbedingte Inappetenz und Insomnie. Seit heute Morgen Vomitus zweimal (flüssig, gelblich, Essensreste, kein Blut) und Diarrhoe einmal (wässrig, braun, kein Blut).

Sie hat irreguläre Menstruation und letzte war vor 40 J. aber eine Gravidität wurde verneint.

Sie berichtet auch Fieber: gestern 38,8°, heute 39,9 rektal gemessen. **Ansonsten ist die weitere vegetative Anamnese unauffällig.**

Sie hat seit 10 J. Hypothyreose nimmt regelmäßig dagegen L-Thyroxin 100 µg. Sie leidet auch an chronische klopfende Cephalgie 1-2 Mal pro Monat und nimmt dagegen bei Bedarf Ibuprofen 400 mg.

Die Patientin nimmt gelegentlich Amphetamine (Speed) wegen des Stresses in der Arbeit.

In der Familienanamnese gibt es Morbus Crohn.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Akute Appendizitis. An Differentialdiagnosen sind zu nennen, Divertikulitis, Extrauterin Gravidität, Ovarialtorsion, Urolithiasis.

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen (Mc-Burney-Punkt, Blumberg-Zeichnen); dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, CRP, BSG, ggf. PCT, Leber-Nierenwerte, E-lyte, Glukose, β-HCG und ein Urinstatus. ✓

Anschließend ist ein EKG und eine Sonographie des Abdomens. Weiterführend ist ein chirurgische Konsil anzufordern.

Ich werde sie stationäre aufnahmen.

Als Therapie schlage ich initial/symptomatisch Flüssigkeits und Elytsubstitution (Infusiontherapie), *Antiemetika, Antipyretika, Analgetikum (Metamizol) b.B.*, und Antibiotikum prä-OP (Ciprofloxacin) vor.

Wurmfortsatz *

Bei gesicherter Verdachtsdiagnose empfehle ich Laparoskopische Appendektomie vor.

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

5

-Fragen

Abdomen Sonographie: Verdickte Appendix > 6mm.

- freie intraabdominelle Flüssigkeit, insbesondere im Douglas Raum (Excavatio rectouterina): manchmal
- falls Wandverdickung: „Kokarde" im Querschnitt: Wand – Lumen – Koprolith
- wichtig für Differenzialdiagnosen: Ausschluss

Warum machen wir einen EKG, kann es ACS sein? Es kann sehr selten sein aber die Patientin nimmt Amphetamin und hat Herzstolpern und hat auch Emesis und Diarrhö (E-Lyte>>HRST)

Kommission: ja richtig und es ist eine Routine Untersuchung in der Notaufnahme

Aufklärungen:

- **Blumberg-Zeichen:** eine kontrolateralen Loslassschmerz
- **Schilddrüsenhormonen:** T3 (=Triiodthyronin), fT4 (= Thyroxin)

Definition: Unter einer Appendizitis versteht man die Entzündung der Appendix vermiformis (= der Wurmfortsatz)

Bakterien, Kunststoffe,

Ätiopathogenese: Koprolithen, Abknickungen, Parasiten (E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae) ☐ Obstruktion des Wurmfortsatzlumens ☐ Entleerungsstörung ☐ Entzündung ☐ Appendizitis

Stadien:

kein Eiter

- **Katarrhalische** Appendizitis ist ein nicht destruktives (nicht zerstörendes) reversibles (heilbares) Stadium. Der Appendix ist gerötet, geschwollen und schmerzhaft. Es ist noch kein Eiter entstanden und die Entzündung kann in manchen Fällen durch Aufsetzen von Eisbeuteln und Nahrungs~~entzug~~ zurückgebildet werden
  Kühlung einstellung
- **Ulzero-phlegmonöse** Appendizitis ✓
- **Gangränöse** Appendizitis
- **Perforierte** Appendizitis (lebensbedrohliche Komplikation der Appendizitis):
  - gedeckt: perithyphlitischer Abszess
  - ungedeckt: perforierte Appendizitis mit lokaler oder diffuser Peritonitis

Klinische Zeichen:

- **McBurney Punkt**: Druckschmerz: Mittelpunkt einer Linie zwischen Nabel und Spina iliaca anterior superior rechts
- **Psoas-Zeichen**: bei Anheben des rechten Beines Schmerzen im rechten Unterbauch
- **Blumberg-Zeichen**: kontralaterale Loslassschmerzen (im rechten Unterbauch) nach Palpation des linken Unterbauchs
- **Douglas-Schmerz**: Schmerzen bei Entzündungen des Bauchraums, die während der digitalen Untersuchung des Rektums auftreten (beim Mann: Proust-Raum = Excavatio rectovesicalis)

Alvarado-Score

= ein klinisches Bewertungsschema für die Diagnose einer akuten Appendizitis

7 Punkte => 0,093 Wahrscheinlichkeit

Insgesamt 10 Punkte werden aus klinischen Aspekten und 2 laborchemischen Parametern errechnet:

Schmerzwanderung in den rechten Unterbauch
Appetitlosigkeit
Übelkeit und Erbrechen
Schmerzen im rechten Unterbauch (2 Punkte)

Loslassschmerzen
Fieber (ab 37,3°C)
Leukozytose über 10.000 (Kl 12 Band
Linksverschiebung im Differenzial

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

Patient/ in
Naomi Rosenthal
45 Jahre alt, 1.7.1978
175 cm, 65.3 kg

Datum
29.12.2025

(nur Stichpunkte) aktuelle Beschwerden
- Bauchschmerzen, seit 3 Tagen, am Anfang im Periumbilicalbereich jetzt im rechten Unterbauch
- plötzlich aufgetreten
- stechend, ziehend, progredient
- verschlimmernd bei Bewegung
- 8/10 auf der Schmerzskala

Begleitsymptom:
- Fieber, seit gestern (38,8°C (gestern), 39,9°C (heute))
- Nausea seit gestern
- Vomitus heute Morgen, 2 Mal (flüssig, gelblich, ohne Blut, Essreste)
- Diarrhoe 2 Mal (wässrig, braun, ohne Blut)

Vegetativ-anamnese
- Inappetenz seit gestern
- Dyssomnie wegen Schmerzen
- Nachtschweiß seit gestern

Vorerkrankungen
- Hypothyreose seit 10 Jahren
- Kopfschmerzen seit längerer Zeit (1-2 Mal pro Monat)

OP
- Tonsillektomie als Kind (Komplikation: V.a Sepsis)

Medikamente
- L-Thyroxin 100 µg (1-0-0)
- Ibuprofen 400 mg b.B

gyn
- die letzte Monatsblutung vor 14 Tagen

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

Allergien / Unverträglichkeiten

unauffällig

Genussmittel

Nikotin: unauffällig
Alkohol: unauffällig
Drogen: Joint 1 Mal pro ~~Monat~~ Woche (wegen Stress bei der Arbeit)

Sozialanamnese

- Tätigkeit im IT Bereich
- Stress bei der Arbeit
- in Homosexuelle Beziehung
- ledig
- keine Kinder

Familienanamnese

Vater: 75 Jahre, vor 2 Jahren 2.n. Myokardinfarkt
Mutter: 65 Jahre, 2.n. Kniegelenkoperation
Schwester: Morbus ~~Crohn~~ ~~Chron~~ Crohn

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

(benutzen Sie Fachwörter, wo möglich) Verdachtsdiagnose

akute Appendizitis

Differentialdiagnose

Urolithiasis
Adnexitis
Ovarialtorsion
Morbus ~~Chron~~ Crohn

weiteres Procedere

- KU
- Vitalparameter
- EKG
- Labor: gr. BB, Entzündungsparameter (CRP), β-HCG, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytewerte, Urinstatus, Stuhldiagnostik
- Sonographie – Abdomen
- Röntgen Abdomen
- ggf. CT-Abdomen
- ein Konsil in Chirurgie

Therapie

- stationäre Aufnahme
- Nahrungskarenz
- Flüssigkeitszufuhr
- Antibiotika (Cefuroxim + Metronidazol)
- Analgetika (~~Metamizol~~ Metamizol)
- ggf. laparoskopische Appendektomie

Danach

Warum gibt es Wanderung bei Appendizitis?

Die Schmerzen wandert von der Periumbilikalregion in den rechten Unterbauch, weil die Entzündung vom viszeralen auf das parietale Peritoneum übergeht (gereizt)

Adnexitis → ✓ Haben Sie Ausfluss oder einen unangenehmen vaginalen Geruch bemerkt?

Was spricht dafür Adnexitis?

Fieber, einseitigen Unterbauchschmerzen und eitriger vaginaler Fluor ~~[illegible]~~ sprechen für eine Adnexitis

Therapie

bei der Appendizitis werden Antibiotika mit Wirkung gegen gramnegative (E. coli) und anaerobe (Bacteroides fragilis) Keime eingesetzt.

z.B. Piperacillin / Tazobactam oder eine Kombination aus Ceftriaxon und Metronidazol

Häufigste Ursache für Peritonitis → Perforation (Appendix)

Digitale rektale Untersuchung (DRU)

Die digitale rektale Untersuchung dient bei Appendizitis dem Nachweis eines Druckschmerzes im Douglas-Raum, insbesondere bei pelviner Lage des Appendix, sowie dem Ausschluss anderer rektaler oder gynäkologischer Ursachen

Die digitale rektale Untersuchung ist bei Appendizitis nicht routinemäßig indiziert, sondern nur bei unklarer Diagnose oder Verdacht auf pelvine Lage des Appendix sinnvoll. ✓

? Peritonitis → sofort external Abdomen Übersicht Aufnahme (Luftgarnbild im Abdomen)

↓

laparoskopische Operation

↓

Arenol

↓

Antibiotikagabe

Chol-CPT

Bei Verdacht auf Peritonitis erfolgen sofort Stabilisierung nach ABC, Blutentnahme und Blutkulturen, Beginn einer empirischen AV. Antibiotikatherapie, Volumentherapie, Analgesie, Bildgebung (wenn Patient stabil ist), und frühzeitige chirurgische Konsultation